



零 -ZERO- / 零式 臨床講座

臨床評価 スターターキット

手技を増やす前に、見る順番を決める。

足関節から顎まで — 評価の順番チェックシート

原口慶篤(整体師・パーソナルトレーナー/人体解剖実習5回/オステオパシー修了/延べ200名以上が受講)

このシートの使い方

施術しても戻る、説明に自信が持てない — その多くは、手技の数ではなく「何をどの順番で見るか」が決まっていないことから起こります。

- 初回の評価で、上から順にチェックしていきます(全部で7部位)
- 「気になる」に付いた項目から、アプローチの候補を考えます
- アプローチのあと、**同じ項目をもう一度チェック**します(再評価)。変わらなければ、仮説を切り替えます

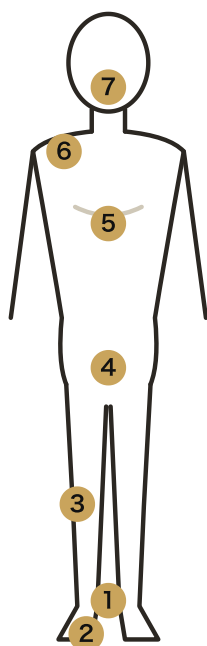


零式の基本:評価 → 選択 → 再評価

型を当てはめる前に、評価して、選んで、確かめる。このシートは、その流れを毎回同じ順番で回すための道具です。

※このシートは評価の観点を整理するためのものです。強い痛み、しびれ、外傷直後などのレッドフラッグがある場合は、医療機関の受診をすすめてください。

評価の順番チェックシート



部位	見るポイント	気になる
1 足関節	非荷重と荷重で背屈の差/踵骨の向き/距骨の前方への動き	☐ 左 ☐ 右
2 足部・歩行	踵接地後の足部の倒れ込み/母趾での蹴り出し/骨盤の左右の揺れ	☐ 左 ☐ 右
3 膝・股関節	スクワットでの膝の向き/股関節の内旋・外旋の左右差	☐ 左 ☐ 右
4 骨盤・腰部	立位の骨盤の傾き/前屈・後屈で動きが止まる位置	☐ あり
5 胸郭・呼吸	呼吸時の胸とお腹の動き/胸郭の回旋の左右差	☐ あり
6 肩甲帯・頸部	挙上時の肩甲骨の動き/頸部の回旋・側屈の左右差	☐ 左 ☐ 右
7 顎・頭部	開口時に下顎がまっすぐ下りるか/開口の大きさ/舌の位置	☐ あり

アプローチ後の再評価

変えた部位	変わった項目	変わらなかった項目 → 次の仮説

部位別:なぜ見るか・どう見るか(1/2)

1 足関節

なぜ見るか:荷重時の衝撃吸収と前方への移動を担う。背屈が出ないと、膝・股関節・腰が代わりに動く

テスト:①非荷重で背屈角度 ②Knee to Wall(壁から何cmで膝がつくか) ③踵骨の向き(立位で後方から)

判定の目安:非荷重は出るのに荷重で減る → 立ち方・足部の安定の問題が混ざっている可能性

よくある誤り:「硬い」=ふくらはぎ、と決めつける

2 足部・歩行

なぜ見るか:柔らかい足(衝撃吸収)から硬い足(蹴り出し)への切り替え

テスト:①踵接地直後の足部の倒れ込み ②母趾で最後に押し出せるか ③骨盤の左右の揺れ

判定の目安:切り替えが遅い → 上の関節が代償している可能性

よくある誤り:上半身から整えて歩くと戻る、を繰り返す

3 膝・股関節

なぜ見るか:膝は股関節と足関節の「間」で振り回されやすい

テスト:①スクワットでの膝の向き ②股関節の内旋・外旋の左右差 ③片脚立ちでの骨盤の傾き

判定の目安:股関節の内旋制限 → 膝が内に入る代償の可能性

よくある誤り:膝の痛み=膝だけを見る

4 骨盤・腰部

なぜ見るか:上半身と下半身の力の通り道

テスト:①立位の骨盤の傾き ②前屈・後屈で動きが止まる位置 ③SLRの左右差

判定の目安:動きが一か所で止まる → その上下の関節の可動性を確認

よくある誤り:「骨盤の歪み」で説明を終える

部位別:なぜ見るか・どう見るか(2/2)

5 胸郭・呼吸

なぜ見るか:姿勢と自律神経、肩甲骨の土台

テスト:①呼吸時の胸とお腹の動き ②胸郭の回旋の左右差 ③呼吸数(1分)

判定の目安:胸だけで呼吸 → 首肩の補助筋が働き続けている可能性

よくある誤り:呼吸を評価項目に入れていない

6 肩甲帯・頸部

なぜ見るか:腕の動きと頭の位置を支える

テスト:①挙上時の肩甲骨の動き(リズム) ②頸部の回旋・側屈の左右差 ③肩をすくめた癖

判定の目安:肩甲骨が動かず上腕だけで挙げる → 胸郭・前鋸筋を確認

よくある誤り:首肩だけ緩めて終わる

7 顎・頭部

なぜ見るか:頭の位置・舌・呼吸と強く関わる

テスト:①開口時に下顎がまっすぐ下りるか ②開口の大きさ(指何本分) ③舌の位置

判定の目安:開口ですれる → 首肩の相談でも顎の使い方を確認。痛み・開口障害は歯科へ

よくある誤り:顎は歯科の領域、と評価から外す

再評価で見る指標

①可動域(角度・cm) ②痛みの強さ(0～10) ③動作の質(左右差・代償の有無) — アプローチの前後で、同じテストを同じ条件で。

記入例:「施術しても戻る肩こり」の場合

部位	所見	気になる
1 足関節	右の背屈:非荷重は十分、荷重で減る/Knee to Wall 右6cm・左10cm	右
2 足部・歩行	右の踵接地後に足部が内に倒れ込む	右
5 胸郭・呼吸	胸だけで呼吸、呼吸数22回/分	あり
6 肩甲帯・頸部	右の挙上で肩甲骨の動きが遅い/頸部の左回旋で張り	右

仮説 → 選択 → 再評価

仮説:右足部の安定が弱く、立位で右肩をすくめてバランスをとっている。呼吸の浅さも首肩の緊張を強めている。

選択:①右足部・足関節へのアプローチ ②呼吸の再教育

再評価:Knee to Wall 右6→9cm/呼吸数22→16回/肩の重さ7→3。首肩に直接触れなくても変化 → 仮説は有効。

※記入例はよくある流れを示したもので、特定の症例ではありません。

評価の前に確認するレッドフラッグ

- 安静時・夜間にも強い痛みがある/痛みが日に日に強くなる
- しびれ・脱力・感覚の低下、排尿・排便の異常
- 外傷の直後、発熱や原因不明の体重減少をとまなう
- 胸の痛み、息苦しさ、強い頭痛やめまい

ひとつでも当てはまる場合は施術を行わず、医療機関の受診をすすめてください。

この先の学び方

① 7日間講座(LINEで毎日届きます)

足関節・歩行・姿勢・筋膜・顎・解剖実習 — このシートの各部位を、なぜそこを見るのかまで解説します。

② 無料コミュニティ

全国のトレーナー・セラピストと、評価の考え方を共有する場です。招待リンクは講座の中でお送りします。

③ ZERO MEMBERS(有料)

毎月最終日曜21:00～23:00のZoom勉強会、会員限定記事、アーカイブ、症例相談。

<https://noriatsu3377-hue.github.io/ZERO-/members.html>

④ 零式セミナー

関節調整法・ヘッドコンディショニング-極-・経絡ストレッチ ほか。

<https://noriatsu3377-hue.github.io/seminars/>